

JUAN RAIMUNDO TOKOS

IDADE: 43 PESO: 88 ALTURA: 1.69 PROFISSÃO:
 SINTOMAS: *Sonolência*
 QUEIXAS: *negas*
 MEDICAMENTOS: *Akelol / Bx te m ba / Rosuvast. / AAS / glicage 2x*
Vit B12 / Vit B3
 MÉDICO: *Dr. Mário Carregosa*

EXERCÍCIO FÍSICO: *1x* LANCHE: JANTAR:

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: HORA QUE ACORDA: *8hr.*

HORA QUE DORME: *2:00-3:00* DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

COCHILO ☒ SIM () NÃO BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO () SIM () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO: *2x*

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *globo* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: IAH: *25.3* SPO2: *83%*

OVERLAP: MALLAMPATI: CPAP: *6 cmH₂O*

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA *I AM*

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS *stent. / coronária*

na severa

2016 CA de célula de merem

Químio e Rádio - em 2017

11/10 P= 8.7 cmH₂O Bem adaptado, s/ queixas.

23 m. de uso: 6h5' IAH= 4.0 e/ev

26/10 P= 8.8 cmH₂O IDO= 3.9% Tempo 0%

23 IAH= 5.0 e/ev M. de uso: 5h52

Bem adaptado, sua.

27/11 P= 8.9 cmH₂O sua.

23 IAH= 4.5 e/ev M. de uso: 6h11'

Bem adaptado

09/01 P= 9.0 cmH₂O (pi). Finalizar doc.

24 IAH= 3.7 e/ev M. de uso: 6h35'

Fuga= 25.8 comprou sua.

09/02 P= 8.5 cmH₂O o mesmo R\$5300.

24 IAH= 4.2 e/ev M. de uso: 6hr

Fuga= 29.3 sua.

08/03 P = 8,7 cmH₂O
IAH = 3,6 e/ev
m. de uso: 6h 10'
fuga = 23,2 lpm.

fua.

10/05 P = 8,6 cmH₂O
24 IAH = 4,2 e/ev
m. de uso: 6h
fuga = 0,6 lpm / 23,6 lpm

fua.

17/07 P = 8,5 cmH₂O
24 IAH = 3,7 e/ev
m. de uso = 6h

fua claudia

19/09 P = 8,8 cmH₂O
24 IAH = 4,8 e/ev
m. de uso: 6h 20'
fuga = 0,4 lpm.

fua

07/05 P = 7,9 cmH₂O
25 IAH = 3,5 e/ev
m. de uso = 5h 47'

fua claudia

04/08 P = 6-8 cmH₂O
25 IAH = 4,2
m. de uso: 0,5 ~~h~~
fuga = 0,5 lpm.

Relata que o CPAP está
fazendo barulho

fua claudia

Juan Ramon Tokos

Paciente com indicação
de uso de CPAP na presença
de 6,0 cm H₂O. Neumia aguda pós.

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.280

Dr(a).

CRM:

-
- ☐ Rua Marcondes Salgado, 115 - Tel.: (12) 3878-5000 - São José dos Campos-SP
 - ☐ Av. Edouard Six, 80 - Tel.: (12) 3953-1044 - Jacareí-SP
 - ☐ Rua Cel. João Dias Guimarães, 266 - Tel.: (12) 3221-1000 - Caçapava-SP
 - ☐ Rua Prof. Luis Augusto Silva, 87 - Tel.: (12) 2125-0333 - Taubaté-SP

Nome: JUAN RAIMUNDO TOKOS
Data de Nascimento: 20-04-1950
IMC: 31,51
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-01-2014

Peso: 90 kg
Altura: 1,69 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-01-2014, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

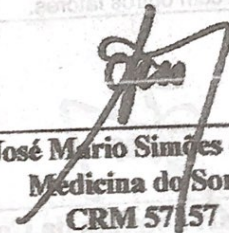
O tempo total de registro foi de 419,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 10,5 e 220,0 minutos. O tempo total de sono foi de 227,5, eficiência de 54,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 61,5%; estágio N3: 22,0%; sono REM: 14,1%. O índice de microdespertares foi de 17,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 25,3, sendo elas 50 obstrutivas, 0 mistas e 0 central e 46 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 83%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 59 bpm e NREM de 48 - 60 bpm. O paciente roncou intensamente.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 25,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=83%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: JUAN RAIMUNDO TOKOS

Data de Nascimento: 20-4-1950

IMC: 30,81

Sexo: Masculino

Data do exame: 07-06-2023

Peso: 88 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 07-06-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 451,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 36,0 e 135,5 minutos. O tempo total de sono foi de 331,5 min, eficiência de 73,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 53,5%; estágio N3: 21,9%; sono REM: 22,5%. O índice de despertares foi de 9,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 13,4/hora, sendo 40 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 34 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 89%, permanecendo 0,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 53 bpm e NREM de 45 - 56 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. registro de ronco durante o sono.

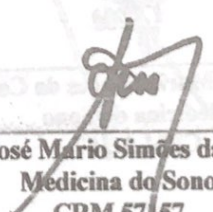
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57